

Dialysis CDSS 主頁面導覽手冊

版本：2026-05-04 demo / 測試版

這份文件用來協助同事第一次使用 [Dialysis CDSS](#) 查房工作台。主頁面分成三個大欄位：左側系統列、中間床位總表與提醒、右側病人詳情。建議使用流程是：先登入，從中間選擇班別與病人，再到右側查看或更新病人資料。

注意：目前 demo 版資料為測試資料或模擬資料，不可直接用於正式臨床決策。正式使用前仍需確認資料來源、院內規則、權限與通知流程。

一、左側系統列

左側淡藍色區塊是系統導覽與登入區。

1. 目前使用者與角色

登入後會顯示目前使用者與角色，例如：

- ? 管理員
- ? 醫師
- ? 護理長
- ? 護理師

不同角色可編輯的範圍不同。沒有編輯權限的頁面仍可查看，但不能修改。

2. 頁面切換

左側 [頁面](#) 可切換不同功能：

- ? [查房工作台](#)：主要工作畫面，查看床位、提醒與病人詳情。
- ? [病人清單](#)：維護目前洗腎室病人、床位、頻率、班別與轉出資訊。
- ? [人員設定](#)：維護使用者、角色、帳號與密碼。
- ? [本院藥物清單](#)：維護洗腎相關藥物品項，供洗腎藥物頁面下拉選單使用。
- ? [規則設定](#)：調整 ESA、鐵劑、CKD-MBD 等建議規則門檻。

3. 模糊病人資訊

勾選 [模糊病人資訊](#) 後，畫面會以遮罩方式顯示病人姓名與病歷號，例如 [黃O全](#) 或部分隱藏病歷號。這只影響畫面顯示，資料庫仍保留原始資料。

4. 重新同步 CSV

[重新同步 CSV](#) 用於重新讀取本機 CSV / 匯入資料並同步到 SQLite。未來若由院內系統定期匯出抽血資料，也會走類似的同步概念。

二、中間床位總表與提醒區

中間欄位是查房時的「病人選擇區」。目標是快速找到今天要看的病人。

1. 床位總表人數

標題會顯示目前名單總人數，例如 [床位總表 | 12 人](#)。目前床位總表只顯示尚未轉出的病人。

2. 頻率與班別篩選

可直接點選頻率與班別，不需要下拉選單。

? 頻率：例如 [一三五](#)、[一五](#)、[二四六](#)

? 班別：例如 [午班](#)、[早班](#)

頻率與班別會依現有病人資料動態產生。若新增病人使用新的頻率或班別，查房工作台會自動出現該選項。

3. 搜尋

搜尋框可用來搜尋：

? 姓名

? 病歷號

? 床號

適合在病人數增加後快速定位病人。

4. 目前篩選摘要

篩選後會顯示目前條件與人數，例如：

[一三五](#) > [午班](#) | 3 人

這代表目前清單是 [一三五](#) 頻率、[午班](#) 的 3 位病人。

5. 今日提醒

[今日提醒](#) 目前主要顯示到期且尚未處理的醫護交班。

提醒卡片顯示床號與病人姓名。點選提醒卡片後，系統會自動切換到該病人的醫護交班紀錄，方便直接處理。

6. 病人列表

病人列表顯示目前篩選條件下的病人，格式簡化為：

[床號](#) [病人姓名](#)

點選病人後，右側會顯示該病人的詳情。被選取的病人會以較明顯底色標示。

三、右側病人詳情區

右側是主要工作區。上方先顯示病人摘要，下方用頁籤切換不同資料。

1. 病人摘要列

最上方顯示：

- ? 病人姓名
- ? 病歷號或識別碼
- ? DW
- ? AK
- ? 藥水 Ca
- ? 透析頻率
- ? 班別
- ? 床位

這區讓查房者不用進入表格，就能先看到最重要的透析資訊。

2. 頁籤總覽

右側目前包含 6 個頁籤：

- ? [主要問題](#)
- ? [近期事件](#)
- ? [醫護交班](#)
- ? [透析醫囑](#)
- ? [洗腎藥物](#)
- ? [治療趨勢與調整建議](#)

前 5 個頁籤採相同操作邏輯：上方是可展開的新增區塊，下方是既有或歷史累積紀錄。預設會先收合新增區塊，方便使用者先閱讀紀錄。

四、各頁籤功能

1. 主要問題

用途：記錄病人的長期疾病背景與目前待處理問題。

新增主要問題時可選擇問題類別：

- ? [Underlying disease](#)
- ? [現在待處理問題](#)

同一筆問題可以同時屬於兩個類別。下方會分成兩段顯示：

- ? [Underlying disease](#)
- ? [現在待處理問題](#)

可記錄欄位包含主要問題、狀態、負責角色、問題類別、更新者、更新時間與備註。新增或修改 [現在待處理問題](#) 時，可觸發外部通知設定，例如 LINE 或 email。

2. 近期事件

用途：記錄近期急診、住院、門診或重要臨床事件。

新增欄位包含：

- ? 事件日期
- ? 事件類型：急診、住院、門診
- ? 事件標題：血管通路問題、心臟問題、感染問題、周邊血管問題、呼吸衰竭、其他
- ? 事件內容

下方會累積既有近期事件，方便查房醫師快速掌握病人最近狀況。

3. 醫護交班

用途：建立針對特定病人與目標日期的交班提醒。

新增欄位包含：

- ? 目標日期
- ? 交班類型：共同交班、醫師交班、護理交班
- ? 優先度
- ? 事件標題
- ? 交班內容

若目標日期到期且狀態仍未完成，會出現在中間欄位的 [今日提醒](#)。點選提醒卡片可直接跳到該病人的交班紀錄。

4. 透析醫囑

用途：記錄或調整透析處方。

新增 / 調整欄位包含：

- ? 生效日期
- ? 透析日：一到六用點選方式選擇，系統會自動解讀為頻率
- ? 班別：早班、午班、晚班
- ? 床位
- ? AK
- ? 藥水 Ca
- ? Blood flow
- ? Dialysate flow
- ? Dry weight
- ? 抗凝 Loading
- ? 抗凝 Maintain
- ? 血管通路側別與類型：左 / 右、FVC / PERM / AVF / AVG
- ? 備註

下方 [既有透析醫囑](#) 會保留歷史紀錄，用來追蹤不同時間點的處方變化。

5. 洗腎藥物

用途：新增或調整透析相關藥物，並追蹤藥物變化。

新增 / 調整欄位包含：

- ? 調整 / 新增日期

- ? 類別
- ? 品項
- ? 劑量
- ? 單位
- ? 頻率
- ? 狀態
- ? 醫囑 / 藥品碼
- ? 備註

類別與品項來自左側 [本院藥物清單](#) 的設定。點選下方既有藥物矩陣中的一列，可自動帶入既有品項、劑量與頻率，儲存後會新增一筆調整紀錄，不會覆蓋舊資料。

下方 [既有洗腎藥物](#) 目前以調整日期作為欄位，藥物作為列，中間顯示當時的劑量與頻率，方便比較治療介入的時間序列。

6. 治療趨勢與調整建議

用途：整合抽血趨勢、洗腎藥物、透析醫囑與規則引擎建議。

此頁面分成幾個層次：

- ? 重點摘要：顯示 Hb、P、cCa、iPTH、Kt/V 等目前狀態與趨勢。
- ? 累積趨勢表：以月份為欄位、檢驗項目為列，異常值會用底色標示。
- ? 治療介入時間軸：顯示日期、藥名或醫囑項目、變動內容與更新者。
- ? 建議區塊：依貧血 / ESA / 鐵劑、CKD-MBD、透析充分性與醫囑分組呈現。

若醫師同意建議，可建立藥物或醫囑調整草稿，再回到 [洗腎藥物](#) 或 [透析醫囑](#) 確認並正式儲存。

五、權限概要

目前測試版權限概念如下：

功能	醫師	護理長	護理師
主要問題	可編輯	可編輯	可編輯
近期事件	可編輯	可編輯	可編輯
醫護交班	可編輯	可編輯	可編輯
透析醫囑	可編輯	可查看	可查看
洗腎藥物	可編輯	可查看	可查看
病人清單	可編輯	可編輯	可查看
人員設定	可編輯	可編輯	可查看
本院藥物清單	可編輯	可查看	可查看
規則設定	可編輯	可查看	可查看

六、建議查房操作流程

1. 從左側登入，確認目前角色正確。
2. 進入 [查房工作台](#)。
3. 在中間欄選擇頻率與班別。
4. 查看 [今日提醒](#)，優先處理到期交班。
5. 從病人列表點選病人。
6. 右側先看病人摘要列，確認 DW、AK、藥水 Ca、班別與床位。
7. 依序查看主要問題、近期事件與醫護交班。
8. 需要調整時，再展開新增區塊新增資料。
9. 若要看月抽血與治療反應，切到 [治療趨勢與調整建議](#)。
10. 若同意建議，先建立草稿，再到醫囑或藥物頁籤確認後儲存。

七、測試版注意事項

- ? Demo 版可供同事操作流程，但不應放入真實病人資料。
- ? 若使用真實資料庫測試，建議開啟 [模糊病人資訊](#)。
- ? 抽血資料目前可由匯入檔案或模擬資料提供；正式串接前仍需資訊室確認資料格式。
- ? 藥物與醫囑目前以前台輸入為主，日後可再評估是否串接 HIS。
- ? 規則建議只作為輔助提醒，正式臨床處置仍需醫師判斷與簽核。